

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	小兒腹膜透析評核表	編號	A31000-Q06-F-D14
	制定 單位	護理部	版本	第 1.4 版
			修正日期	110 年 12 月 13 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：請受試者以口述或實際操作。

三、評核內容：

- 核對醫囑及辨識病人（至少二種以上方法），並向病人或家屬解釋小兒腹膜透析技術目的及填寫同意書。
- 洗手。
- 排空膀胱，避免膀胱穿刺。
- 協助病童適當擺位並作適宜的約束。
- 依醫囑適當的給予鎮靜劑密切觀察病童生命徵象。
- 協助醫師洗手後戴口罩、髮帽、無菌手術衣後再戴無菌手套，以 2%Tr Idoine 及 75% Alchoh 三次消毒穿刺部位後以無菌技術遞治巾、小眼洞巾、刀片、彎 mosquito 1 支、Tenchhoff 導管或胸管、針線(3.0 Dermalon)、持針器給醫師。
- 協助醫師插入腹膜透析管後用縫線將腹膜透析管固定在皮膚上。
- 護理人員以無菌技術將腹膜透析管與引流瓶接好以布膠固定，並檢查各連接處是否固定、套牢、緊密。
- 以 0.9% N/S、B-Iodine CD 後以 Y 紗固定胸管，再以無菌紗布覆蓋 Mifex 固定。
- 追蹤 KUB 確認管路位置，若位置正確予以進行腹膜透析。
- 將透析液接上精密 bag 及精密尿量桶並加溫（事先加入 Heparin 500u）。
- 每公斤以 10 ml 的透析液，在 10 分鐘內給完，停留在腹腔 20 分鐘，並持續 30 分鐘放液。
- 記錄腹膜透析紀錄單及護理紀錄。
- 觀察及記錄引流液之性質、顏色、量、引流速度，腹膜透析管穿刺部位傷口情形及放置時間、病童反應、生命徵象等。
- 整理單位，清洗用物後歸位後洗手。
- 觀察及記錄病童有無不良反應，如：觀察有無腹膜炎的症狀例如：發燒、嗜中性白血球上升、白血球上升、透析液混濁。

